

ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ

Γενικά: Ουδεμία άλλη άρθρωση του σώματος δεν υφίσταται τόσο συχνά συνδεσμικές (διαστρέμματα) ή άλλες κακώσεις όσο η ποδοκνημική (ΠΔΚ) άρθρωση. Η έξω πλευρά της ΠΔΚ τραυματίζεται με πολύ μεγαλύτερη συχνότητα (85%) από ό,τι η έσω πλευρά (15%). Στην ΠΔΚ άρθρωση ο σύνδεσμος που συχνότερα υπόκειται σε ρήξη είναι ο έξω πλάγιος.

Κλινική εικόνα: Συνήθως υπάρχει έντονος τοπικός πόνος, οίδημα, εκχύμωση κάτω και εμπρός από το έξω σφυρό και περιορισμός της κινητικότητας της άρθρωσης, ανάλογα με τη βαρύτητα της κάκωσης. Τα κατάγματα της ΠΔΚ δεν είναι μεμονωμένες οστικές κακώσεις, αλλά συνοδεύονται από σοβαρές ρήξεις συνδέσμων, ενώ πάντα πρέπει να ελέγχεται και η σπονδυλική στήλη, ιδίως επί πτώσης από ύψος. Ιδιαίτερη σημασία έχει η κλινική εκτίμηση ολόκληρης της επιφάνειας της ΠΔΚ για τραύματα, που δυνατόν να επικοινωνούν με τις επιφάνειες του κατάγματος. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία που παρουσιάζουν ευαισθησία. Εάν εντοπιστεί άλγος ή ευαισθησία πάνω στον σύνδεσμο, κατά την ψηλάφηση ή τις παθητικές κινήσεις, τότε πρόκειται πιθανόν για συνδεσμικό ή θυλακικό τραυματισμό.

Ακτινολογικός έλεγχος: Οι προσθοπίσθιες, έξω και πλάγιες λήψεις (βάσει των κανόνων της Οττάβα - *The Ottawa Rules*) έχουν ιδιαίτερη σημασία για την εκτίμηση της κάκωσης, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις αξονική τομογραφία της ΠΔΚ πιθανώς να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Σημειώνεται, εδώ, ότι καλύτερη απεικόνιση των καταγμάτων του έσω σφυρού επιτυγχάνεται με πρόσθετη λήψη, διατηρώντας το άκρο πόδι σε γωνία 45° έσω στροφής.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Ελέγχουμε τα ζωτικά σημεία (ΑΠ, σφύξεις-HR, SpO₂) και ψηλαφούμε τον σφυγμό στον άκρο πόδα ή τον ελέγχουμε με συσκευή u/s-Doppler. Η αντιμετώπιση επικεντρώνεται, αρχικά, στη διάγνωση-ταξινόμηση του κατάγματος ή του διαστρέμματος της ΠΔΚ.
2. Τοποθετούμε – αν χρειαστεί – φλεβική γραμμή με ορό 500-1000 ml NaCl 0,9% ή R/S.
3. Χορηγούνται αναλγητικά και μυοχαλαρωτικά: 1 amp. Voltaren + 1 amp. Musco-Ril (im), και 1 amp. Apotel-plus (im)· εναλλακτικά χορηγείται 1 amp. Dynastat/Coxidem (iv) και 1 fl. Apotel 1 gr, στάγδην. Επί αφόρητου πόνου, 1 amp. Μορφίνη ή Zideron ή Tramadol.
4. Τα κατάγματα της ΠΔΚ άρθρωσης είναι ενδοαρθρικές κακώσεις, που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση και προσεκτική ανάταξη, για την επίτευξη ικανοποιητικών μακροχρόνιων αποτελεσμάτων. Για την επίτευξη ανάταξης με κλειστούς χειρισμούς, είναι απαραίτητο οι ειδικοί να γνωρίζουν την κατεύθυνση των δυνάμεων, που προκάλεσαν την κάκωση. Το συντομότερο δυνατό, μετά τον τραυματισμό, θα πρέπει να γίνεται ανύψωση, ανάταξη και ακινητοποίηση του άκρου, ώστε να περιοριστεί το οίδημα. Εφόσον έχει χορηγηθεί επαρκής αναλγησία, ο κύριος χειρισμός ανάταξης για τα περισσότερα πλάγια κατάγματα είναι πελματιαία κάμψη και έσω στροφή. Αυτό επιτυγχάνεται ανυψώνοντας το πόδι του τραυματία κρατώντας το από το μεγάλο δάκτυλο, ενώ ο ασθενής βρίσκεται ύπτια κατακεκλιμένος. Η ακινητοποίηση γίνεται σε αυτή τη θέση με κατάλληλο νάρθηκα. Η επιτυχία της θεραπείας εξαρτάται από την άμεση και σταθερή ανάταξη του τραύματος.
5. Ασταθή κατάγματα της ΠΔΚ πρέπει να αντιμετωπίζονται απαραίτητα στο Νοσοκομείο, με ανάταξη και εσωτερική σταθεροποίηση, εφόσον εκδηλωθεί σημαντικό οίδημα στην περιοχή. Κατά τη διακομιδή, φροντίζουμε να τοποθετηθεί στο άκρο ειδικός διάφανος αερονάρθηκας air-splint ή γυψονάρθηκας (οπίσθιος, αφού πρόκειται για το κάτω άκρο).
6. Σε ρήξη συνδέσμων ή επί διαστρέμματος 1^{ου} βαθμού εφαρμόζεται ελαστική επίδεση για 2-3 εβδομάδες και επαρκής κινησιοθεραπεία. Σε ρήξη ή διάστρεμμα 2^{ου} βαθμού γίνεται ακινητοποίηση σε ΚΠ γύψο για 4-6 εβδομάδες και σε ρήξη ή διάστρεμμα 3^{ου} βαθμού η αντιμετώπιση είναι κατά κανόνα χειρουργική, δηλαδή η συρραφή του συνδέσμου και τοποθέτηση γύψου για 6-8 εβδομάδες, με τακτική επανεκτίμηση της κλινικής πορείας.